

35 - La Mortalité Maternelle - Pr. FAKHIR

Bonjour, aujourd'hui, on va parler de la mortalité maternelle. Donc, c'est un cours de santé à manier des études médicales dans le cadre de l'université de gynécologie obstétrique. Alors, quel est l'intérêt de parler de la mortalité maternelle ? Eh bien, l'intérêt est grand et très important parce que c'est un problème de la santé publique, pas uniquement au niveau national, mais aussi au niveau mondial et international.

Et aussi parce que la mortalité maternelle survient à cause de causes évitables, c'est-à-dire qu'on peut éviter, surtout si on a un système de santé efficace. Le taux de mortalité maternelle est un indicateur de la qualité du système de santé d'un pays. D'ailleurs, les pays sont évalués ou leur système de santé sont évalués par l'OMS, par exemple, et d'autres organismes internationaux sur la base du taux de mortalité maternelle.

Plus le taux de mortalité maternelle est élevé, plus le système de santé du pays est considéré comme insuffisant ou défaillant. Le taux de mortalité maternelle est très influencé par l'équité à l'accès du soin à l'intérieur d'un pays. Pour le Maroc, sur plusieurs années et plusieurs dizaines d'années, il y a eu plusieurs programmes et stratégies qui se sont mis en place pour améliorer la mortalité maternelle.

Cette mortalité maternelle a été effectivement améliorée de façon objective, mais il est bien évidemment nécessaire de fermer. Sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne un intérêt très important à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle dans les pays. Puisque, comme on expliquait juste maintenant, c'est un indicateur de la qualité du système de santé du pays.

Pour la définition, la mortalité maternelle concerne le décès d'une femme qui survient au cours de la grossesse ou dans un bébé les 42 jours après sa terminée. Par cause quelconque, les terminés ont aggravé par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés. Mais ce n'est ni un décès accidentel, ni pour tout.

C'est-à-dire qu'on appelle mortalité maternelle le décès de toute femme qui se fait soit au cours de la grossesse ou dans les 42 jours après, et la cause de ce décès, elle est déterminée ou aggravée par la grossesse elle-même. Il y a aussi la définition de la mort maternelle tardive, c'est la mort d'une femme au cours du cycle vital indirect au-delà des 42 jours après la fin de la grossesse, mais au moins d'un an après. Malgré le fait que cette mort maternelle tardive est causée par des événements liés à la grossesse, ces décès-là ne sont pas comptabilisés comme des décès maternels dans le système d'enregistrement de l'état-cible.

Donc, on considère que la mortalité maternelle vraie, c'est quand c'est inférieur à 42 jours. Mais au-delà et pendant l'année, c'est vrai que c'est une mort maternelle tardive, puisque généralement la cause est liée à la grossesse, mais sur le plan administratif, elle n'est pas

comptabilisée comme des décès maternels. Statistiquement, on calcule le taux de mortalité maternelle, qui représente le risque associé à chaque grossesse, ou ce qu'on appelle le risque obstétrical.

C'est le nombre de décès maternels, comme on l'a défini tout à l'heure, surveillant pendant une année, pour 100 000 naissances vivantes pendant la même période. C'est-à-dire qu'on prend le taux de mortalité maternelle, c'est le nombre de décès maternels en une année, par 100 000 naissances vivantes. On entend par naissance vivante, d'enfant vivant, l'expulsion ou l'extraction complète du corps de l'amiant, c'est un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de mort.

Donc c'est particulier, parce que là, on comptabilise juste les naissances et les morts. Vous comprenez que sont exclues de là les morts totales in utero, les décès corps par corps, les avortements, etc. Et donc, la mortalité maternelle et le taux de mortalité maternelle est lié à ce nombre d'enfants vivants.

Pour vous donner une idée sur l'importance de ce phénomène, c'est la mortalité maternelle ou le décès maternel, dans la grossesse, soit dans les 42 jours après la fin du CSI, sachez qu'au Maroc, chaque jour, on a à peu près 1 800 enfants qui tombent enceintes. 730 connaissent des problèmes de santé impliquables dans la grossesse, donc c'est à peu près 40 %. Puis, 274 nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence, donc à peu près 15 %. Et 18 à 73 courent le risque de développer un diabète gestationnel, donc à peu près 1 à 4 %. Et puis, 36 à 55 courent le risque d'une éclampsie, donc 2 à 3 sont toutes les grossesses. Ceci veut dire que le nombre de grossesses est important dans notre pays, et donc les risques de complications liées à la grossesse ou liées à l'accouchement sont importants aussi.

Ce qui fait qu'il y a un risque de mortalité maternelle. Et dans le cadre de notre système de santé, eh bien, on se prévient qu'à peu près 2 femmes, chaque jour, meurent de causes hérissables liées à la grossesse et à l'accouchement. Vous allez entendre parler de causes hérissables, pourquoi ? Parce qu'il a été établi que la plupart des causes de décès liées à la grossesse sont des causes hérissables.

C'est-à-dire qu'on peut les éviter en faisant un bon suivi de la grossesse, c'est-à-dire une bonne consultation générale, qui va nous permettre de dépister justement les problèmes de santé implicables à la grossesse, tels que l'hépatisme sontarien, tels que le diabète, tels que les insertions anormales des placentas qui vont donner des moratisations, etc. Et ça va nous permettre d'indiquer des césariens prophylactiques et donc d'éviter les complications liées à la dyslossie, par exemple, qui peuvent se compliquer de rupture de couvrines, c'est compliqué de déchirure des vages génitales et donc des mortalités post-partum. Ceci aussi va nous permettre de traiter les pathogénies associées à la grossesse à temps et non pas être surpris plus tard par les décompensations comme dans les cardiopathies, comme pour les asthmatiques, comme pour les nécrophathies, etc.

Et donc, si on a un système de santé qui permet de faire un bon suivi de la grossesse et donc de dépister tous ces problèmes, de les traiter, de les gérer à temps, tout simplement on aura une diminution nette des fréquences de la mortalité maternelle. Parce qu'à ce moment-là, on aura géré les problèmes à distance de l'extrême urgence, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que la patiente arrive en décompensation pour qu'on puisse la traiter, on ne va pas attendre le travail alors que la patiente a une contre-indication à la voix basse, et là, ça peut arriver ou ça arrive dans les milieux les plus éloignés, dans le milieu rural, et donc la patiente n'est pas suivie, on ne connaît pas, par exemple, les usines importantes, on ne connaît pas la présentation et elle attend le travail alors qu'elle a une présentation transverse. Et donc, quand elle rentre au travail à un grand centre de santé qui est à côté d'elle, on ne peut pas la coucher et on a besoin de la transférer pour une longue distance, ce qui augmente le risque d'un côté d'une rupture terrible, mais d'un autre côté de la souffrance fatale et du décès périnatal.

Et bien évidemment, cette patiente quand elle arrive au milieu hospitalier où elle a besoin d'une césarienne, et bien ça va trouver la césarienne en extrême urgence avec tous les risques de complications, affectueuses, troubles homologues, etc., qui sont connus, liés à la césarienne en urgence. Si on la compare à la césarienne prophylactique. Donc, vous voyez que si on réfléchit au circuit de la patiente enceinte et puis de la patiente qui accouche, on comprend facilement que beaucoup de complications et de mortalité survient secondairement et des causes qui sont évitables si on réalise ou si on a un système de santé qui fait un bon suivi des patients.

On peut calculer aussi quel est le risque de décès maternel sur la durée de vie. En fait, c'est la probabilité qu'une jeune femme décèdera un jour, donc aussi à la grossesse ou à l'accouchement. Et bien, sachez que c'est aux alentours de 1 sur 4900 dans les pays développés, et que c'est contre 1 sur 180 dans les pays en développement, donc c'est la différence très importante, et que ça peut atteindre les 1 sur 54 dans les pays connus par leur fragilité et par l'effondrement de leur système de santé dans les pays liés à la guerre, etc.

Et donc, ça veut dire que chaque femme a un risque sur 54 de mourir au cours de sa grossesse, pendant toute sa vie. Donc, vous voyez que la différence est très grande entre les pays développés et les pays en développement, parce que justement, c'est un indicateur du développement d'un bébé. Ici, c'est une carte mondiale qui est publiée par l'OMS en 2015, et qui met en évidence le taux de mortalité maternelle par 100 000 naissances vivantes.

Et on remarque que les pays nordiques et l'Amérique, donc étonnamment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ils ont des taux de mortalité maternelle diminués. Le Maroc est situé dans la tranche entre 100 et 299 des taux maternels par 100 000 naissances, ce qui reste encore élevé. Et on remarque que les pays de l'Afrique subsaharienne, du central, ont des taux de mortalité très élevés, qui peuvent atteindre jusqu'au 1000 par 100 000 naissances vite vivantes, ce qui est un taux très élevé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de système de santé qui suit les grossesses correctement, et qui indique les gestes prophylactiques avant la survie des

complications en Australie.

Sur ce diagramme, on remarque l'évolution du taux de mortalité maternelle au Maroc à partir des années 70, où le taux de mortalité était élevé, mais on voit que la diminution se passe jusqu'en 2010, vraiment c'est une diminution, mais qui reste très très très ralentie, donc pour à peu près une quarantaine d'années, on a diminué le taux de mortalité au un tiers. Et on remarque facilement que le milieu rural est victime de mortalité maternelle plus sûr que le milieu urbain, et ça se comprend facilement, par exemple, ici en 2009-2010, le milieu urbain remplace 113 000 naissances vivantes, le milieu rural quand même 148, presque le double d'un milieu rural, avec une moyenne à 112. Donc ceci signifie qu'il y a ce qu'on appelle une inégalité à l'accès aux soins entre le milieu urbain et le milieu rural.

Les femmes qui sont suivies et soignées dans les grandes villes, elles ont plus de chances d'avoir un suivi et un accouchement plus sécurisé que les patients qui sont au milieu rural, où il y a une difficulté à l'accès aux soins, où les hôpitaux sont loin, où les routes ne sont pas faciles à utiliser, donc il y a ce qu'on appelle des zones qui sont enclavées, donc il y a un enclavement dans certaines zones, qui fait que par exemple, si une patiente a besoin d'un soin heureusement océfical, par exemple accouchement ou saignement ou autre chose, il y a un enclavement géographique qui fait qu'il y a du retard dans la prise en charge. Et on le sait très facilement que la prise en charge obstétrique est dépendante du délai de prise. Si on prend en charge la patiente à temps, généralement tout se passe bien et on a beaucoup moins de complications, mais s'il y a un retard de prise en charge, bien évidemment, les complications arrivent facilement.

Donc ici on voit facilement qu'il y a quand même une différence très importante entre la mortalité maternelle dans le milieu rural et dans le milieu urbain, et qui est expliqué facilement aussi par l'inégalité à l'accès aux soins médicaux dans le milieu rural. Encore une courbe qui arrive jusqu'à 2014, on a les derniers chiffres liés par les instances du ministère de la Santé au Maroc, et c'est 83 décès maternels par 100 000 naissances vivantes, c'est le taux de mortalité maternelle. C'est un taux qui est amélioré par rapport à 332 dans le cadre des années 80, mais ça reste quand même un chiffre à améliorer selon les recommandations de l'OMS.

Si on compare la mortalité maternelle au Maroc par rapport aux pays voisins, notamment la Génée, la Tunisie, la Libye et l'Egypte, on voit quand même que le Maroc a un peu de retard par rapport à l'amélioration de la mortalité maternelle. On voit que la Tunisie, depuis 1995, avait des chiffres assez intéressants. L'Egypte aussi a pu réduire le taux de mortalité maternelle, et que le Maroc, au moins jusqu'en 2005, avait besoin de plus d'actions pour l'amélioration de la mortalité maternelle.

Alors quelles sont les causes de la mortalité maternelle ? Eh bien, très clairement, on peut avancer que la difficulté d'accès aux obsèques et aux dépouillances constituent la première cause de la mortalité maternelle. C'est-à-dire qu'on va pas parler des causes inévitables, parce que ces causes-là, on a compris qu'elles sont évitables. Et pourquoi elles ne le sont pas dans

certaines pays ? C'est parce qu'il y a une difficulté d'accès aux obsèques et aux dépouillances.

Et les soins d'obsèques et de dépouillances, c'est l'accouchement, c'est la tuilerie, c'est le traitement d'hémorragie, la délivrance, la prise en charge. Puis, il y a la disparité entre milieux et entre religions. Comme on a expliqué, pour le milieu rural, il y a l'enclavement.

Donc si, par exemple, on est en saison de neige, il y a un enclavement, les zones qui sont complètement bloquées, et donc les patients ne peuvent pas traverser pour arriver à l'hôpital, ou bien arriver à l'hôpital. Et, heureusement, on va dire que ces dernières années, il y avait ce qu'on appelle l'hélicoptère-mur, c'est-à-dire le transport aérien pour les extrêmes d'urgence, et qui a permis, par exemple, de faire acheminer un certain nombre de patients vers l'hôpital de Marrakech, par exemple. Mais, ce n'est pas du tout suffisant, puisque, comme on a expliqué un peu auparavant, les hôpitaux d'urgence, c'est vrai que c'est au moment du travail, au moment de l'accouchement, au moment où la complication survient, mais la prévention réelle de la mortalité maternelle, se base sur un bon suivi de la grossesse, c'est-à-dire une bonne consultation prénatale.

Alors, la consultation prénatale, on va voir, a fait partie de tous les programmes les plus récents au Maroc pour un peu l'améliorer et un peu augmenter le taux de couverture de cette consultation-là, mais elle reste insuffisante et elle reste peu spécialisée, puisqu'elle est faite par des sage-femmes ou des généralistes, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Les causes aussi peuvent être l'insuffisance aux ressources humaines, donc les faits qu'on ne peut pas couvrir tous les territoires marocains, accueil et qualité de prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d'urgence insuffisants, c'est-à-dire que même au sein d'un hôpital d'une maternité, on se retrouve avec des soins insuffisants, soit par manque de moyens humains, soit par manque de moyens matériels, soit par manque de formation, ou encore par un débordement en nombre, c'est-à-dire qu'une maternité va travailler à 180%, c'est-à-dire le double de sa capacité, ce qui fait que la qualité de la prise en charge des soins est... Pour les principales causes médicales, justement de la grossesse, et ici c'est un rapport national de l'enquête confédérale sur les décès maternels qui a été publiée en décembre 2008, on retrouve que l'hémorragie constitue la première cause, 33%, suivie des complications de l'hypertension artérielle et de la grossesse prééclampsie ou éclampsie, suivie par la suite par les autres causes, suivie par l'infection, la rupture érythro-membranaire et les autres causes directes, ça peut être la vie thrombotique, ça peut être les complications opératoires, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hémorragie est la première cause de décès maternel, suivie des complications de l'hypertension et de l'enceinte, notamment la prééclampsie et l'éclampsie.

Alors, il y a les causes obstétricales directes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la définition d'un décès par causes obstétricales directes ? C'est un décès qui résulte de complications obstétricales directes, notamment de la grossesse, du travail, de suite de couches. Il résulte d'interventions ou d'omissions, ou d'un traitement incorrect, ou d'un enchaînement d'événements résultant à l'un des facteurs suivis. C'est-à-dire qu'on est devant une patiente qui est enceinte,

soit qu'elle est toujours enceinte, soit qu'elle est en travail, ou en période de manque de couches, et chez qui soit on a fait une intervention médicale, ou bien on n'a pas fait l'intervention médicale nécessaire, ou on l'a fait incorrectement, ce qui va entraîner un ensemble de problèmes qui vont aboutir au décès maternel pour causes obstétricales directes.

Pour causes obstétricales indirectes, le décès résulte d'une maladie préexistante, ou d'une infection au cours de la grossesse, sans qu'elle soit due à des causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse. Et là, ça peut être les cardiopathies, surtout, ça peut être les néphropathies, ça peut être la maladie thromboembolique, etc. Alors, comme on a expliqué, les causes obstétricales indirectes, ça constitue 80% des causes du décès maternel, l'hémorragie, les troubles hypertensifs de la grossesse, la prééclampsie et les complications, c'est-à-dire le syndrome, la fièvre, etc.

Les infections, notamment l'infection chronique, mais il existe aussi les travaux prolongés, puis les complications de l'abandon à risque aussi. Alors que les causes obstétricales indirectes, c'est à peu près 20%, donc c'est maternel, et c'est comme les cardiopathies, les anémies sévères, les néphropathies, etc. Sur ce tableau, il y a la définition du décès maternel, la définition du décès par cause directe, le décès par cause indirecte, et il y a ce qu'on appelle la mort maternelle fortuite ou accidentelle.

Et là, c'est un décès qui survient lors de la grossesse ou dans les suites de couches, mais dont les causes n'ont aucun rapport avec la grossesse, c'est-à-dire une patiente qui a eu un accident de la voie publique alors qu'elle est enceinte, on ne peut pas comptabiliser ça comme une mortalité maternelle. Une patiente qui a eu une piqûre de scorpion, la même chose. Puis, il y a les morts maternelles tardives.

Là, on a expliqué que ça peut être une cause liée à la grossesse, mais au-delà des 42 jours et moins d'un an, mais elle n'est pas comptabilisée dans les autres mortalités maternelles. Alors, à titre indicatif, au niveau national, depuis les années 70, comme on avait dit, il y a eu plusieurs stratégies qui se sont suivies pour améliorer justement le taux de mortalité maternelle. Avenir, c'est-à-dire le décès obligatoirement.

Et donc, il y a eu des programmes de protection maternelle, protection maternelle et néonatale, et puis les programmes de soins gynécologiques et obstétricaux. Et puis, l'apparition des soins obstétricaux et néonataux d'urgence qui ont été organisés sous forme d'un modèle bien organisé. Et enfin, à partir de 2008, l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale est devenue une priorité des ministères, des différents ministères de la santé qui se sont écoulés.

Et ceci, bien sûr, suivait donc l'attente ou les recommandations de l'organisation mondiale de la santé. Et aussi parce que cela permettait à notre pays de pouvoir améliorer ses indicateurs de développement qui, bien évidemment, ouvrent plusieurs portes vers justement le monde extérieur. Les bases de l'élaboration, elles-mêmes reposent sur ce qui a été fait avant,

évidemment, des études nationales et des recherches nationales, mais aussi des évidences scientifiques et des études de la recherche internationale, ainsi que la benchmarking internationale et les expériences des autres pays.

Et ceci a été évident dans le cadre de l'élaboration de 2012, mais par la suite aussi dans le plan de 2012-2016, dans lequel ont été prises en considération les recommandations du Forum international sur la lutte contre la mortalité maternelle, les rapports de consultation internationale sur la santé néonatale, les analyses des données générées par les études locales, etc. Tout ceci a permis l'élaboration du plan 2012-2016, dans lequel ont été clairement identifiés les objectifs à atteindre, mais aussi les étapes à suivre, notamment dans la promotion de la consultation prénatale, dans l'augmentation des taux de césarienne, l'amélioration de l'accès aux soins, l'amélioration de la couverture géographique, mais aussi l'amélioration des ressources humaines, des ressources matérielles, dans le cadre de la santé de la femme et de l'environnement. Plus récemment, on entend parler des objectifs de développement durable et de stratégie mondiale.

Eh bien, elle concerne aussi la mortalité maternelle, puisque la santé maternelle est citée dans l'objectif 3.1. Et je cite, d'ici 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au bout de 70% en 1982. En fait, les objectifs de l'OMS aussi, c'est-à-dire que d'ici 2030, d'avoir une moyenne de mortalité maternelle mondiale qui ne dépasse pas 70% en 1920. C'est-à-dire que les pays dont les taux sont élevés sont rappelés pour essayer de diminuer rapidement le taux de mortalité maternelle.

Alors, l'OMS collabore avec ses partenaires et les différents pays afin de lutter contre les inégalités dans l'accès aux services de soins de santé génétique maternelle et immuno mentale, ainsi que dans la qualité de ces services. Donc, il ne suffit pas qu'on ait l'accès pour que les services soient de qualité, d'assurer la couverture sanitaire universelle pour les soins complets, santé génétique, maternelle et immuno mentale, de lutter contre toutes les causes de mortalité maternelle, de renforcer les systèmes de santé pour répondre aux besoins et aux priorités des femmes et des jeunes filles, et de veiller à la responsabilisation pour améliorer la qualité des soins et l'équité. L'ensemble de volets sont la clé du renforcement des systèmes de santé qui aboutit généralement à l'amélioration de la mortalité maternelle.

Alors, pour les stratégies nationales, déjà, il y avait des objectifs à l'horizon de 2016, c'est-à-dire certains sont atteints, mais pas en totalité. Alors déjà, à l'horizon de 2016, on avait comme objectif d'augmenter la couverture des accouchements en milieu surveillé de 73 à 90%, et de 55 à 75% pour les milieux ruraux. Donc, ici, c'est un critère très important, le fait que les patientes accouchent dans un milieu médical surveillé est un gage, justement, des qualités de soins.

Atteindre un taux de césarienne de 10%, augmenter la couverture en CPN, c'est-à-dire en consultation prénatale, de 70 à 90%, atteindre une couverture de 95% par la consultation de postpartum, maintenir un taux de prévalence contraceptive supérieur à 76%. Ces éléments-là, ce sont les éléments clés de l'amélioration de la prise en charge de la femme en femme, et bien

évidemment, si on arrive à les améliorer, ceci améliorer la mortalité maternelle. L'objectif était aussi de réduire la mortalité de sons 12 à fait qu'on décède par 100 000 naissances vivantes, et de réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour 1 000 naissances vivantes.

Actuellement, la mortalité maternelle et les soins maternels sont liés étroitement, soignés et matos, parce que, bien évidemment, la grossesse ou l'accouchement compliqué va retentir sur la maman, et bien évidemment, va retentir sur le nouveau-né aussi. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs ou pas ? Pas encore, mais il y a des programmes de renforcement de cette stratégie-là. L'accès aux soins, il fallait franchir un certain nombre de barrières.

Par exemple, en 2008, il y avait la gratuité de l'accouchement et de la césarienne dans le secteur public. En 2012, en plus de la gratuité du bilan de la grossesse, la prison charge des complications obstétriques. En 2010, il y a eu le lancement du SAMU obstétrique.

Entre 2008 et 2010, il y avait l'acquisition de 182 ambulances par le ministère de la Santé. Le SAMU commence en 2012. On voit qu'il y a des actions qui sont effectuées, mais elles devraient être encore plus renforcées.

L'accès et la qualité des soins. La stratégie nationale pour accéhumaniser les maternités et les maisons d'accouchement. Renforcer la capacité litière.

Investir dans l'équipement. Assurer la disponibilité de soins et médicaments effrangibles au niveau des maternités et des hôpitaux avec maternité. Renforcer l'effectif des sages-femmes, l'effectif des obstétriciens, l'effectif des réanimateurs, et aussi renforcer les compétences par la formation continue.

La gouvernance est une partie importante dans la réussite d'une stratégie ou d'un programme pour arriver à des objectifs précis. Les axes sur lesquels se basent les stratégies nationales, c'est un accompagnement du niveau central par une commission nationale et un comité national d'experts. Un renforcement de la responsabilité de proximité, donc déclinaison du plan d'action national au plan d'action régionaux, c'est-à-dire que chaque région doit être responsable de ses résultats et de l'application de la stratégie.

Un ciblage du milieu rural et des zones sous couverte, c'est le plan d'action 2013-2015 pour 9 régions. Et puis, il y avait un programme conjoint 2015-2016 d'appui au plan d'action de la réduction de la mortalité maternelle et mémonatale. L'évolution des taux de recrutement en CPN est un indicateur dans le cadre de la stratégie de la réduction de la mortalité maternelle et mémonatale.

Jusqu'en 2014, on a vu une augmentation en pourcentage de la couverture de recrutement de la CPN, qui est en bleu, donc on voit qu'il est passé de 32% à 75%. Et puis, l'accouchement en milieu surveillé, qui est passé de 32% à 80% entre 1994 et 2014. Les naissances en milieu surveillé par rapport aux naissances attendues, donc on voit qu'il y a une amélioration des

naissances en milieu surveillé.

Le taux de césarienne en secteur public, on voit qu'on est arrivé en 2014 à 9,18%, ce qui reste encore insuffisant, puisque les recommandations, c'est entre 10 et 15%. Mais si on compare le secteur public au secteur privé, on va trouver une différence très importante, puisque le taux de césarienne peut atteindre des fois jusqu'à 30% dans le milieu privé, dans le secteur privé. Et enfin, une dernière rapproche sur l'évolution du taux de mortalité maternelle avec le dernier chiffre de 2015, qui est de 75 par 100 000 naissances vivantes.

Donc voilà, la mortalité maternelle est un problème majeur de santé publique, pas uniquement national, mais plutôt international. C'est un indicateur du développement d'un pays, et donc tous les pays ont intérêt à améliorer rapidement le taux de mortalité maternelle. La mortalité maternelle est souvent évitable, comme on a expliqué, et donc ça s'est influencé par le circuit de l'attente enceinte, par l'éloignement, par l'enclavement, par la pauvreté, par l'absence de consultation prénatale.

Et dans les pays où la consultation prénatale a une place importante dans le suivi des conseils, la mortalité maternelle peut atteindre 0 par 100 000 naissances. Les causes multiples peuvent être liées aux compétences, mais surtout liées à l'organisation. Et la prévention de mortalité maternelle est possible, mais elle est possible en passant par un système de soins bien organisé et surtout efficace.